

专题研究报告

国内外生物医药发展现状、趋势演进与市场空间

核心观点

行业界定与商业价值判断。生物医药产业是指以基因工程、细胞工程、发酵工程、核酸编辑、蛋白质工程等现代生物技术为基础，以药品研制、生产与销售为核心，并向上下游延伸至关键原料、装备与专业化服务的产业集群。它由化学药、生物药、现代中药三类技术体系共同构成；三类产品共享监管与支付环境，却在底层技术、产能约束和资本定价上显著不同。2025 年生物制品是少有的高增长板块，传统化药和中药继续承压。其价值不止于制造业增长，还叠加供应链安全、长周期经济回报和对冲老龄化负担。资本层面，全球并购回暖以应对专利悬崖，中国则形成股权融资与 BD 首付款并行的多柱支撑，估值重心由管线叙事转向可成交、可推进、可全球兑现的资产质量。

全球生物医药发展现状：格局与重心。以药品销售终端口径计，全球医药市场约 1.79 万亿美元，北美、欧洲、亚太主导；中国按药品销售口径约占 12%，稳居第二大单一国家市场。生物药占比首次超过化学药，大分子时代到来。头部企业依然集中，但礼来等因重磅品种一年改写座次，显示单品足以重塑竞争位势。美国靠资本驱动原始创新，欧洲重监管与供应链韧性，中国靠工程师红利和平台效率实现追赶。美欧强化关键药品与供应链安全，跨国药企为填补到 2032 年或超 3700 亿美元的增长缺口加速外部引进，中国成为重要标的来源。

国内生物医药发展现状：追赶与突围。中国生物医药在“总量承压”与“结构跃升”的双重轨迹中完成关键跨越。2025 年，中国生物医药整体市场规模约 2.24 万亿元人民币，占全球比重升至约 18%（医药工业口径）。中国已是全球第二大医药市场，但仿制药过剩和热门靶点同质化仍突出，集采推进到第十一批，持续挤压低效供给。突围集中在 ADC、双抗等创新赛道，以及具备全球交付能力的 CXO；审评从单纯加速转向提质，商保创新药目录与基本医保“双目录”开始分轨运行。国际化完成由引进为主到授权出海为主的逆转，合作模式由早期低价出让，更多转向更高首付款、共同开发和平台合作。

行业趋势演进：全球与中国的双轨变革。全球与中国两条线正在咬合：一边是跨国药企“外部寻宝”，一边是中国在支付改革、监管引导和出海升级中积蓄系统能力。AI 有望缩短研发周期、提高成功率，有助于缓解扎堆热门靶点；支付端商保被视作创新药的重要增量，但目前占比仍低，制度红利转化为患者可及仍需时间。

市场空间测算。以 2025 年工业营收约 2.96 万亿元为基数，基准情景假设未来五年年均增长 6.5%至 7.5%，对应 2030 年约 4.05 万亿至 4.24 万亿元；谨慎与乐观情景分别落在约 3.6 万亿至 3.8 万亿、4.55 万亿至 4.65 万亿元。增长驱动力主要来自商保扩容、出海升级和研发效率提升，结构优化比总量扩张更重要。

结论与建议。中国已从全球医药的跟跑者，变为影响供给和交易格局的关键变量，但仍处“数量领先、首创不足”的爬坡期。未来五年看点不在简单做大规模，而在创新结构、支付体系和全球竞争力能否闭环。建议把出海作为能力升级路径，加快商保与多元支付建设，并以 AI 和数字化推动从快速跟进走向更多原始创新。

发展研究 · 专题研究

证券分析师：陶鹏春
0755-81982322
taolic@guosen.com.cn
S0980511040002

相关研究报告

风险提示：政策不及预期。

内容目录

1. 行业界定与商业价值判断	5
1.1. 行业定义与分类：三块拼图，三条增长曲线	5
1.2. 行业发展历程：从仿制跟随到创新驱动的四次跃迁	7
1.3. 行业价值评估：三重价值叠加的战略高地	8
1.4. 行业投融资现状：全球再配置与中国融资重构	8
2. 全球生物医药发展现状：格局与重心	12
2.1. 全球市场规模与区域格局：基本盘稳定，亚太崛起加速	12
2.2. 全球竞争格局与龙头企业布局：头部集中与三种创新模式	13
2.3. 全球研发热点与政策重心：技术平台化与供应链区域化双轨并进	16
3. 国内生物医药发展现状：追赶与突围	17
3.1. 产业规模与结构性痛点：全球占比提升，内卷与过剩并存	17
3.2. 细分领域突围现状：创新药全球竞争力显现，CXO 面临地缘重构	19
3.3. 政策与支付环境：从“加速审批”到“全链条支持”	20
3.4. 国际化现状：从 License-in 到 License-out 的历史性逆转	22
4. 行业趋势演进：全球与中国的双轨变革	23
4.1. 全球趋势演进：技术迭代与产业重构	23
4.2. 国内趋势演进：破局内卷与全面出海	25
5. 市场空间预测：基于政策框架的情景分析	26
5.1. 测算框架与方法论	26
5.2. 测算结果：三情景下的市场空间	27
5.3. 增长驱动：三股力量贡献增量	28
6. 结论与建议	28
6.1. 研究结论：全球格局重构、中国角色跃迁、增长瓶颈待破	28
6.2. 发展建议：出海升维、支付补短、技术赋能	29
风险提示	30

图表目录

图 1：生物医药产业链图谱	7
图 2：2015-2025 年中国医疗健康领域融资趋势（单位：件，亿美元）	10
图 3：2025 年国内生物医药企业融资矩阵（单位：亿元人民币）	12
图 4：2015-2025 年中国在研管线全球占比变化（单位：%）	19
图 5：2021-2025 年药品注册申请审结量（单位：件）	21
图 6：2015-2025 年中国药企 Licence-out 交易数量及金额（单位：件，亿美元）	23
图 7：2015-2025 年全球生命科学行业并购趋势（单位：十亿美元）	25
表 1：2025 年医药工业主要子行业增长表现	6
表 2：2023—2025 年全球医药健康领域并购情况	9
表 3：2020—2025 年全球医疗健康一级市场融资情况	9
表 4：2025 年国内生物医药一级市场投资领域分布（已披露金额口径）	10
表 5：2025 年中国生物医药企业 IPO 融资情况	11
表 6：2025 年医药领域十大头部交易	11
表 7：2025 年全球制药企业营收 TOP10	13
表 8：2025 年全球制药企业 50 强——中国企业上榜情况	14
表 9：2025-2026 年全球主要医药市场政策重心对比	17
表 10：2025 年规模以上医药工业主要经济指标（中国医药企业管理协会口径）	17
表 11：2025 年规模以上医药制造业企业主要经营指标（国家统计局口径）	17
表 12：2025 年中国医药工业九大子行业经营情况	18
表 13：2025 年国家药监局审评审批主要成果	21
表 14：2025 年底国家组织药品集采核心数据	22
表 15：AI 赋能下药物研发周期对比	24
表 16：2025 年全球医药交易与并购核心数据	24
表 17：2025—2030 年中国医药工业营收三情景测算（单位：亿元）	27
表 18：2025—2030 年中国创新药市场规模三情景测算（单位：亿元）	27

2026年3月5日，李强总理在十四届全国人大四次会议上作政府工作报告，明确要“打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业”。这是“生物医药”首次与集成电路、航空航天并列进入“新兴支柱产业”序列，产业定位由此实现一次重要抬升：从长期作为战略性新兴产业培育，进一步走向国民经济的增长主战场。与之相应，产业被同时赋予三重任务——培育新质生产力、缓解老龄化与重大疾病带来的健康支出压力，以及在全球医药价值链中争取更高位置。

与政策定位抬升同步，2025年中国医药工业呈现出鲜明的结构性特征。据中国医药企业管理协会《2025年医药工业经济运行情况》，规模以上医药工业企业实现营业收入29562.5亿元，同比下降0.6%；实现利润4080亿元，同比增长1.4%。其中，生物制品子行业营业收入与利润分别同比增长7.5%和37.9%，成为少数实现强势扩张的板块。监管端，国家药监局全年批准创新药76个，创历史新高；市场端，医药魔方数据显示，中国创新药对外授权（License-out）交易总额达1356.55亿美元、首付款70亿美元、交易157笔，各项指标均刷新纪录。工业总量仍有压力，但利润结构、创新供给与全球化交易同步改善，表明产业并不是简单的周期波动，而是处在从仿制主导向创新与出海并行的阶段转换之中。

由此引出需要系统回答的三个问题：中国生物医药目前处在何种产业阶段？未来五年的增长来自哪里？在全球竞争坐标中，中国已经走到哪一步、还差在哪里？单一指标不足以支撑判断。本报告以“界定—描摹—推演—测算”为主线：先在2025年最新证据下厘清化学药、生物药、现代中药的差异；再分别刻画全球格局与中国路径；继而从技术、政策与支付三个维度展望2026—2030年演进；最后基于可核对的官方与权威数据测算市场空间。

1. 行业界定与商业价值判断

1.1. 行业定义与分类：三块拼图，三条增长曲线

生物医药产业是指以基因工程、细胞工程、发酵工程、核酸编辑、蛋白质工程等现代生物技术为基础，以药品研制、生产与销售为核心，并向上下游延伸至关键原料、装备与专业化服务的产业集群。它不是均质行业，而是由化学药、生物药、现代中药三类技术体系共同构成；三类产品共享监管与支付环境，却在底层技术、产能约束和资本定价上显著不同。要判断其商业价值，首先需要把三条增长曲线分开看清。

生物药：大分子的生物表达逻辑。生物药依托活细胞体系表达大分子活性物质，覆盖单抗、双抗、抗体偶联药物（ADC）、疫苗、血液制品、重组蛋白以及细胞与基因治疗（CGT）等。其研发与生产高度依赖重组构建、细胞培养和蛋白纯化，临床层面强调靶向与机制清晰，产业层面则必须面对工艺放大难、单位成本高和冷链约束。2025年，生物制品是医药工业中增长最强的子行业，营收与利润同比分别增长7.5%和37.9%，显示创新大分子与相关制造能力正在成为利润扩张的主引擎。资本侧，ADC、双抗、CAR-T等方向持续吸收一级市场与产业资本关注，具备差异化临床数据的企业更容易获得估值溢价。

化学药：小分子的化学合成逻辑。化学药以合成或半合成小分子化合物为主，作用机制建立在化合物与靶点的生化相互作用之上，具备可口服、便于储运、易于大规模生产等优势；但在肿瘤、自免等复杂疾病中，也更容易碰到耐药与脱靶等问题。2025年，化学原料药营业收入同比下降0.6%、利润下降4.5%，化学制剂营业收入同比下降2.1%、利润下降0.1%，传统仿制药在集采常态化下继续让利。与此同时，具备明确临床差异化并具备对外授权潜力的创新小分子，仍是结构性机

会所在。换言之，化学药并不是“没有机会”，而是机会已经从规模仿制迁移到创新与全球化。

现代中药：传统方剂与现代科技融合的逻辑。现代中药在中医理论指导下，运用现代提取、分离、纯化与制剂技术形成饮片、中成药等产品，需要同时满足多成分、多靶点的传统优势与质量标准、循证证据、机制阐释等现代化要求。2025 年，中药饮片营业收入与利润分别同比下降 6.3%和 3.7%，中成药分别下降 6.0%和 2.9%，存量品种继续调整；但“十四五”期间国家药监局累计批准中药创新药 28 个，说明监管对中药创新并非简单收缩，而是提高了证据与质量门槛。对投资而言，更具辨识度的，是独家品种、配方颗粒、中药创新药以及个别企业向创新药管线延伸的能力，而不是传统普药的规模扩张。

表 1：2025 年医药工业主要子行业增长表现

子行业	营收增速	利润增速	增长特征
生物制品	7.5%	37.9%	高速增长
化学原料药	-0.6%	-4.5%	成熟承压
化学制剂	-2.1%	-0.1%	成熟承压
中药饮片	-6.3%	-3.7%	结构调整
中成药	-6.0%	-2.9%	结构调整
制药专用设备	-4.9%	27.4%	设备先行
医疗仪器设备及器械	3.4%	-3.9%	国产替代

资料来源：中国医药企业管理协会《2025 年医药工业经济运行情况》，国信证券经济研究所整理。

产业链全景：上中下游如何放大板块差异

三大板块的分化，不能只在产品形态上理解，还要还原到产业链位置。生物医药是一个纵向贯通、横向耦合的系统，大致可分为上游、中游和下游。

上游提供原料药、药用辅料、生物反应器、色谱填料、培养基、一次性耗材等基础投入品。生物药对上游的依赖尤其深：分离纯化用色谱填料、高端培养基等关键物料长期由 Cytiva、Merck KGaA 等跨国企业占据主导，国产替代仍在爬坡。2025 年的积极信号在于，纳微科技、蓝晓科技等本土企业在 Protein A 亲和填料、离子交换介质等品类上持续突破；同期制药专用设备子行业利润同比增长 27.4%，说明装备与耗材环节往往比整体制剂更早兑现景气。

中游对应发现、临床前、临床、注册与规模化生产。小分子、大分子、CGT、mRNA 等不同技术平台在此并列，CXO（CRO/CDMO/CMO）则把能力模块化。龙头经营数据比行业估算更能说明景气：截至 2025 年末，药明康德持续经营业务在手订单 580 亿元，同比增长 28.8%，显示研发生产外包需求仍在扩张。

下游决定商业化效率，包括医院、零售、互联网医疗等渠道，以及基本医保、商业健康保险和患者自费等支付安排。2025 年，基本医保与商业健康保险创新药相关安排并行推进，创新药支付环境边际改善；但传统仿制药仍处在集采与价格治理约束下，终端放量并不等于利润同步扩张。

把产业链与三大板块对照，可以看到更清楚的分工：化学药的竞争力更多体现在中游合成、制剂与成本控制；生物药的关键约束和护城河更多位于上游生物制造与纯化能力，以及中游复杂工艺放大；现代中药则同时受上游道地药材质量与中游标准化、循证化进度制约。技术路线不同，决定了研发门槛和生产组织方式不

同；所处生命周期不同，又进一步导致资本愿意支付的久期和风险溢价不同。

图1：生物医药产业链图谱

上游：原材料供应及装备				中游：生物医药生产				下游：流通市场	
中药材	□ 白云山	原料药	□ 新和成	中药	□ 九芝堂	□ 天济草堂	□ 片仔癀	医药流通商家	□ 老百姓 □ 瑞康医药
	□ 同仁堂		□ 浙江医药		□ 广药集团				□ 国药控股 □ 博瑞药业
医药中间体	□ 昆药集团	药用辅料	□ 尔康制药	化学药	□ 康缘药业	□ 新天药业	□ 敬和堂		□ 九州通 □ 大参林
					□ 安邦制药				□ 华润湖南 □ 益丰大药房
培养基	□ 森萱医药	生物原料	□ 山河药辅	生物药	□ 恒瑞医药	□ 复星医药	□ 东风药业		医院
	□ 天宇股份		□ 威尔药业		□ 博瑞医药		□ 天地恒一		
装备	□ 富祥股份	生物原料	□ 尔康制药	生物药	□ 康源制药	□ 泰邦生物	□ 复星医药		基层卫生医疗机构
	□ 奥浦迈		□ 蓝晶微生物		□ 天坛生物		□ 斯奇生物		
装备	□ 澳斯康	生物原料	□ 微构工厂	生物药	□ 康泰生物	□ 复星医药	□ 斯奇生物		专业卫生医疗机构
	□ 多宁生物		□ 中科国生		□ 源品生物				
装备	□ 德荣医疗 □ 东富龙	生物原料	□ 微构工厂	生物药	□ 康泰生物	□ 复星医药	□ 斯奇生物		专业卫生医疗机构
	□ 可孚医疗 □ 新华医疗		□ 微构工厂		□ 康泰生物				

资料来源：前瞻产业研究院，国信证券经济研究所整理。

1.2. 行业发展历程：从仿制跟随到创新驱动的四次跃迁

中国生物医药并不是一条平滑上升的曲线，而是由若干制度节点推动的跳跃式演进。

第一阶段：起步奠基期（1949—1978 年）。以青霉素、链霉素等抗生素国产化为标志，化学药工业完成最初积累。1953 年第一支青霉素在上海第三制药厂试制成功，1958 年华北制药厂投产，产业目标首先是满足基本用药，技术来源以援助与仿制为主，主体以国有企业为主，品种结构相对单一。

第二阶段：开放引进期（1979—2000 年）。外资进入带来 GMP 与现代药品管理经验，天津中美史克、上海施贵宝等合资药厂先后成立；1985 年《药品管理法》实施，药品监管进入法治化轨道。1990 年代重组人胰岛素、干扰素等第一代生物药出现，生物药开始萌芽；恒瑞医药、复星医药等本土企业成长，民营资本进入行业。2001 年加入 WTO 后，原料药出口快速扩张，中国成为全球重要原料药供应国，但真正意义上的创新药仍基本空白。

第三阶段：快速跟进期（2001—2015 年）。2008 年“重大新药创制”科技重大专项启动，为后续创新提供了组织和资金基础。2011 年埃克替尼等国产小分子靶向药获批，标志产业从纯仿制走向仿创结合；2014 年前后国产 PD-1 等项目进入临床，靶点选择与剂型改良能力增强，但原始创新依然稀缺，主流范式仍是跟随。

第四阶段：创新驱动期（2016 年至今）。真正的转折出现在审评审批制度与资本制度共振之后。2015 年 8 月，国务院印发《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，仿制药一致性评价启动；2017 年中国加入 ICH，注册技术要求加速与国际接轨；2018 年港交所 18A 规则落地，2019 年科创板开板，未盈利生物科技企

业获得公开市场融资通道；2021 年维迪西妥单抗等国产 ADC 获批，标志复杂制剂能力上台阶。到 2025 年，国家药监局批准创新药 76 个；“十四五”期间累计批准创新药 230 个、创新医疗器械 292 个。若再叠加 2026 年政府工作报告对“新兴支柱产业”的表述，可以看到：产业已经不只是政策催熟的新兴行业，而是开始以产品上市、商业化验证和全球交易来证明自身。

从结果指标看，中国创新药在研数量约占全球 30%，医药产业规模位居全球第二。阶段含义也随之变化：更关键的问题不再是“有没有创新”，而是“哪些创新能够完成确证性临床、获得支付支持并在全球市场兑现”。

1.3. 行业价值评估：三重价值叠加的战略高地

生物医药之所以被置于更高的产业位势，是因为其价值并不止于制造业增长本身，而是同时具有战略、经济与社会属性。

战略价值：把关键药品供给掌握在自己手里。新冠疫情之后，主要经济体普遍重新评估医药供应链安全。美国推动医药供应链韧性建设，欧盟推进关键药物相关立法，中国则在 2026 年政府工作报告中将生物医药明确为新兴支柱产业之一。对拥有超大规模人口的国家而言，创新药与关键制剂能力关乎公共卫生安全。2025 年获批的 76 个创新药中，化学药国产占比达 80.85%，生物制品国产占比达 91.30%，说明在上市创新供给层面，国产主体地位已经确立。这并不意味着所有上游卡点都已打通，但确实表明中国已不再只是全球仿制药和原料药供应商。

经济价值：长周期高投入，也对应长周期回报与产业链带动。创新药研发普遍具有高失败率、长周期特征，行业经验上单个产品从发现到上市往往需要约 10—15 年、耗资可达十亿美元量级。一旦形成临床与商业化闭环，专利期与全球市场可以贡献显著回报。2025 年，百济神州核心产品泽布替尼全球销售额达 280.67 亿元，同比增长约 49%，是“研发长期投入—全球销售兑现”的代表性案例。与此同时，创新药景气会向 CXO、原料药、辅料、装备等环节传导，形成比单一制造业更长的带动链条。

社会价值：对冲老龄化和重大疾病负担。肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、代谢性疾病等慢病负担随老龄化上升，社会对更高疗效治疗方案的需求具有刚性。2025 年创新药获批提速，使更多产品能够在国内率先或同步上市。这些创新药在我国率先或同步上市，使广大患者能够更早获得全球生物医药前沿成果的治疗。其中的两类机制需要分开看：国内获批与同步上市，直接改善患者疗效；对外授权交易更多反映中国资产的全球产业价值，并反哺企业后续研发资金，二者相关，但并不等同。至于 CAR-T、双抗、基因编辑等前沿疗法，已在部分适应症上展示出明确临床进展，其社会意义应在具体适应症与证据边界内理解，而不是简单的普适性治愈率数字。

1.4. 行业投融资现状：全球再配置与中国融资重构

2025 年生物医药资本行为的主线，不是简单的“回暖”两字，而是风险偏好重新定价：全球产业资本更急于补齐专利到期后的增长缺口，中国市场则在股权融资之外长出了以 BD 首付款为代表的新现金流支柱。为避免口径混淆，下文将全球与中国、并购与股权融资、生物医药窄口径与医疗健康宽口径分开表述。

全球：并购回暖与股权融资弱复苏并存

跨国药企的并购需求，首先来自即将到来的专利悬崖。安永等机构研究指出，到 2032 年，全球前 25 大药企潜在增长缺口可能超过 3700 亿美元，外延交易因此成

为补管线的重要手段。综合各机构观察，2025 年全球医药健康相关并购较前两年明显更活跃，市场普遍以“金额与数量接近翻倍”来描述这一轮回升；由于各机构统计范围并不完全一致，表 2 给出的是便于比较的约数框架，而非单一官方普查数据。

表 2：2023—2025 年全球医药健康领域并购情况

年份	并购总额（亿美元）	交易数量（笔）	同比变化
2023	约 800	约 450	—
2024	约 800	约 450	基本持平
2025	约 1600	近 900	翻倍增长

资料来源：普华永道、伦敦证券交易所集团、Citeline、Bloomberg Intelligence 综合数据，国信证券经济研究所整理。

注：不同机构对医药/生命科学/医疗健康的统计边界存在差异，表中为便于跨年比较的约数。

股权融资方面，复苏节奏更温和。动脉智库《2025 年全球医疗健康投融资年报》显示，2025 年全球医疗健康一级市场共完成融资 2353 笔，金额 604 亿美元，较 2024 年分别约增 3%和 4%。资金并未均匀撒向所有赛道，而是明显流向 AI 医药、基因治疗、精准医疗等方向。Bessemer Venture Partners 统计，2025 年 AI 相关公司已占医疗科技融资的 55%，高于 2024 年的 37%和 2023 年的 33%。传统仿制药和同质化项目越来越难获得资金，说明全球资本处理的是“未来五年技术方向”，而不是修复旧商业模式。

表 3：2020—2025 年全球医疗健康一级市场融资情况

年份	融资事件数（起）	融资总额（亿美元）	同比变化
2020	1532	386	—
2021	2140	612	58.5%
2022	1896	478	-21.9%
2023	1723	421	-11.9%
2024	1680	593	40.9%
2025	2353	604	4.0%

资料来源：动脉智库《2025 年全球医疗健康投融资年报》，国信证券经济研究所整理。

中国：宽口径医疗健康回暖，窄口径生物医药结构分化

若看医疗健康宽口径，动脉智库数据显示，2025 年国内一级市场达成 861 笔交易、融资约 96 亿美元，结束 2022—2024 年连续三年下行，金额同比上升 32%。分季看，四个季度融资金额同比增速分别为-12%、-17%、77%和 112%，呈典型的“上半年磨底、下半年加速”节奏。

若收窄到生物医药企业口径，中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会《2025 年中国生物医药投融资蓝皮书》提供了更贴近制药创新的观察：2025 年共有 343 家生物医药企业获得一级市场融资，其中 171 家披露融资金额合计 323.54 亿元。治疗领域上，肿瘤仍居首位，披露融资额 141.24 亿元，占 43.6%；免疫系统疾病升至第二，达 95.50 亿元，同比大幅增长 315.22%；内分泌与代谢性疾病为 48.40 亿元，同比增 29.20%。资本行为也更挑剔：更愿意为有临床进度、有差异化机制、

具备对外授权可能性的资产付费，早期纯故事项目的估值泡沫明显收敛。

表4: 2025 年国内生物医药一级市场投资领域分布（已披露金额口径）

治疗领域	融资额（亿元）	占比	同比变化
肿瘤	141.24	43.60%	—
免疫系统疾病	95.5	29.50%	+315.22%
内分泌与代谢	48.4	15.00%	29.20%
其他	38.4	11.90%	—

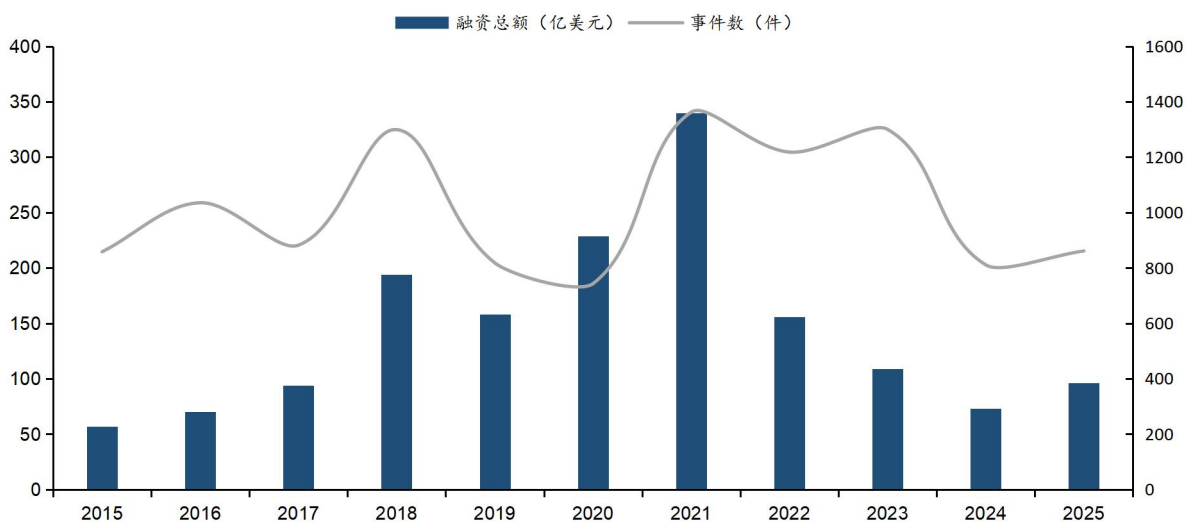
资料来源：中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会《2025 年中国生物医药投融资蓝皮书》，国信证券经济研究所整理。

注：占比基于 171 家已披露融资额企业合计 323.54 亿元计算；“其他”为残余项。

公开市场：港股成为生物科技 IPO 主阵地，再融资同步修复

二级市场股权融资在 2025 年显著修复。蓝皮书统计显示，全年共有 24 家中国生物医药企业完成境内外 IPO，合计募资 292.77 亿元，同比增 129%。其中，港交所 20 家、募资 229.29 亿元，占 78.3%；科创板 3 家、54.66 亿元，占 18.7%；纳斯达克 1 家（亚盛医药）、8.82 亿元，占 3.0%。港股占比高，与 18A 规则对未盈利生物科技企业的包容性直接相关；恒瑞医药港股发行募资 89.01 亿元，是当年最大单笔 IPO。再融资方面，生物医药上市公司完成 29 起、已披露金额 330.39 亿元，药明康德、硕迪生物、百利天恒等金额靠前，资金主要投向管线推进、平台升级与全球化安排。

图2: 2015-2025 年中国医疗健康领域融资趋势（单位：件，亿美元）



资料来源：动脉智库，国信证券经济研究所整理。

表5：2025 年中国生物医药企业 IPO 融资情况

上市地	企业数量	募资金额（亿元）	占比
港交所	20 家	229.29	78.30%
科创板	3 家	54.66	18.70%
纳斯达克	1 家（亚盛医药）	8.82	3.00%
合计	24 家	292.77	100%

资料来源：中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会《2025 年中国生物医药投融资蓝皮书》，国信证券经济研究所整理。

与 IPO、再融资并行的，是产业并购与大型权益交易的活跃。从公开统计的头部交易看，重整收购、控制权收购、定向增发与基石投资等多种工具并用，标的既覆盖综合药企，也覆盖创新药、血液制品、中药和 CXO 相关资产，说明资本退出与产业整合渠道在同步拓宽。

表6：2025 年医药领域十大头部交易

序号	标的名称	投资机构	交易类型	细分领域	交易金额（百万美元）
1	人福医药	招商科创	重整收购	综合性医药	1,610
2	礼新医药	正大制药	控制权收购	大分子抗肿瘤创新药	951
3	和黄药业之中药业务	金浦健服、金浦志伏合、上海医药	控制权收购	中药微粒丸制剂	621
4	南岳生物医药	上海莱士	控制权收购	血液制品	585
5	百利天恒	中欧基金、易方达基金、广发证券等	定向增发	创新型抗体药物及 ADC 药物	530
6	恒瑞医药	GIC Private Limited、Invesco Advisers 等	港股 IPO 基石投资	创新药	528
7	三生制药	未披露	定向增发	创新药	400
8	药明康德之临床研究业务	高瓴资本	非控制权收购	临床研究服务	395
9	重庆医药	通用技术集团	非控制权收购	综合性医药	311
10	常山药业	元素基金	非控制权收购	肝素系列药物	300

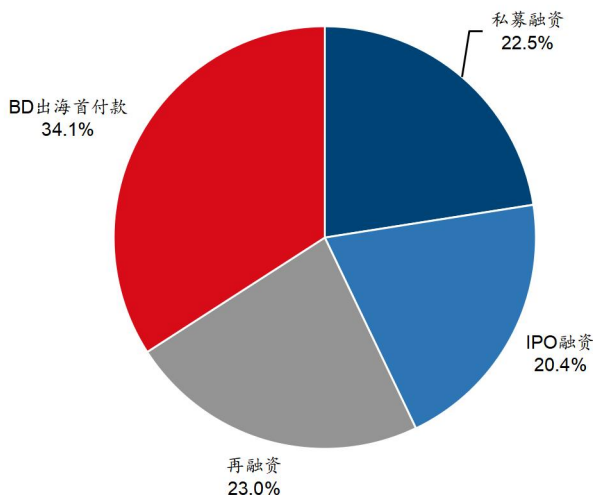
资料来源：汤森路透，普华永道，国信证券经济研究所整理。

BD 首付款：与股权融资并列的现金流支柱

2025 年最重要的融资结构变化，是对外授权首付款上升到可与股权融资并列讨论的位置。按医药魔方统计，全年中国创新药 License-out 交易 157 笔，潜在总金额 1356.55 亿美元，首付款 70 亿美元；相对 2024 年的约 519 亿美元总额、94 笔交易，规模与频次均显著上一个台阶。若与蓝皮书统计的生物医药一级市场已披露融资额 323.54 亿元人民币相比，仅首付款一项已明显高于同年股权融资披露规模；这也是市场认为“BD 正在成为创新药企关键造血方式”的数据基础。需要强调，1356.55 亿美元是合同潜在总额，真正当年可确认的现金以首付款和已实现里程碑为主，分析估值时应避免把潜在总额误读为当年入账金额。

模式上也更丰富。NewCo 等方式不再只是个别案例，开始成为部分企业保留远期权益、引入海外运营能力的选项；“授权收入 + 里程碑 + 销售分成 + 股权安排”的组合，使中国创新资产参与全球分工的方式更灵活。对定价而言，当跨国药企愿意为仍处早期或中期的中国资产支付以亿美元计的首付款时，市场得到的不是又一个模型假设，而是可观察的外部成交锚。

图3：2025 年国内生物医药企业融资矩阵（单位：亿元人民币）



资料来源：中国医药企业管理协会投融资服务专业委员会《2025 年中国生物医药投融资蓝皮书》；国信证券经济研究所整理。

注：BD 数据来源医药魔方，BD 首付款口径，潜在总额 1356.55 亿美元不计入当年入账。

把全球与中国放在一起看，2025 年资本地图的含义已经比较清楚。全球层面，产业资本用并购应对专利到期，风险资本把增量留给 AI 和前沿治疗；中国层面，生物医药企业不再单靠 VC/PE 续命，而是形成“私募股权 + IPO/再融资 + BD 首付款”的多柱支撑。对二级市场定价，这条变化尤其关键：企业价值评估的重心，正从“管线数量与叙事空间”转向“可对外成交、可推进临床、可在全球市场兑现的资产质量”。也因此，创新药与 CXO 龙头更容易获得风险偏好修复，而缺乏差异化的传统仿制药资产，即使处在同一行业指数中，也很难回到上一轮同涨同跌的环境。

2. 全球生物医药发展现状：格局与重心

2.1. 全球市场规模与区域格局：基本盘稳定，亚太崛起加速

2025 年全球医药市场规模约 1.785 万亿美元，同比增长约 4.5%—5.5%（药品终端销售口径）。若按生物医药行业口径测算，规模约 1.70 万亿美元。两个口径的绝对值和成员边界并不相同，但共同指向同一事实：全球医药产业高度集中的格局并未动摇，北美、欧洲、亚太三大区域合计约占全球市场 95%¹。

北美是全球医药产业的核心腹地。美国凭借庞大的临床需求、成熟的支付体系（商业保险+联邦医保+自费）、全球最密集的风险投资网络，以及 NASDAQ 对未盈利生物科技企业的包容，构成“研发—资本—商业化”三位一体生态。2025 年美国单一国家销售金额约 7500 亿美元、占全球约 42%，既是最大体量市场，也是全球创

¹ 为避免与第一部分及后文的区域占比混淆，本报告统一采用“药品终端销售”口径描述区域结构：北美约 42%、欧洲约 30%、亚太约 23%，三者合计约 95%。

新药企的终极目标市场——一款新药能否在美国获批并进入医保，往往决定其全球商业天花板。

欧洲是全球医药产业的“守正者”。凭借 EMA 统一监管体系、深厚学术积淀，以及罗氏、阿斯利康、诺华、赛诺菲等老牌巨头的持续投入，欧洲在疫苗、血液制品、重组蛋白、基因治疗等领域保持优势，2025 年占全球市场约 30%。但欧洲同时面临定价压力（各国医保严格控价）与创新资本外流（大量 Biotech 赴美 IPO 或被美国的跨国药企 MNC 并购）的双重挑战。

亚太是增速最快、变局最大的区域，2025 年占全球市场约 23%。中国是核心引擎——2025 年销售金额约 2100 亿美元、占全球约 12%，为仅次于美国的第二大单一国家市场；印度以约占全球 20% 的仿制药原料药供应能力成为“世界药房”；日本在再生医疗、代谢与肿瘤药物领域专精。亚太内部分工正深刻变化：**中国创新突围、印度供给基石、日本专精特新**的三元格局正在重塑区域生态。

2025 年全球医药市场还发生了一个历史性转折——**生物药占比首次超越化学药、超过 52%**，标志“大分子时代”到来。驱动这一转折的核心力量，是 GLP-1 类代谢药物、ADC、双抗、CAR-T 等生物药的爆发式增长。

2.2. 全球竞争格局与龙头企业布局：头部集中与三种创新模式

一方面，资源向头部高度集中的底层逻辑未变——全球制药、生物技术与生命科学行业总市值约 7.35 万亿美元，市值前十企业合计占全行业约 50%，前 5% 头部企业贡献约 80% 市值。另一方面，座次在一年内剧烈变动：礼来凭替尔泊肽爆发式增长，营收同比猛增 44.7% 至 651.79 亿美元，一举问鼎全球“药王”，并成为全球首家市值破万亿美元的制药公司。这种“格局稳定下的座次剧变”，是 2025 年全球医药竞争的真切写照。

表 7：2025 年全球制药企业营收 TOP10

排名	企业	2025 年营收（亿美元）	同比增速	总部
1	强生	941.93	6.10%	美国
2	罗氏	744.28	1.70%	瑞士
3	礼来	651.79	44.70%	美国
4	默沙东	650	1.00%	美国
5	辉瑞	625.79	-1.60%	美国
6	艾伯维	611.6	8.30%	美国
7	阿斯利康	587.39	8.60%	英国
8	诺华	545.32	9.60%	瑞士
9	赛诺菲	513.95	10.30%	法国
10	百时美施贵宝	481.94	-0.20%	美国

资料来源：医药魔方，国信证券经济研究所整理。

从区域看，TOP10 中美国占六席（强生、礼来、默沙东、辉瑞、艾伯维、百时美施贵宝），欧洲占四席（罗氏、阿斯利康、诺华、赛诺菲），构成全球医药“第一集团”。而在《财富》世界 500 强医药榜中，中国仅国药集团、上海医药、广药集团三家登榜，全球最高层级仍由欧美企业主导。这一分布揭示核心事实：**中国企业攀登全球价值链顶端的征程，既面临挑战，也蕴含巨大潜力。**

表8：2025 年全球制药企业 50 强——中国企业上榜情况

排名	企业名称	备注
第 33 位	云南白药	排名与上年持平
第 39 位	中国生物制药	连续多年上榜
第 41 位	华东医药	首次上榜
第 44 位	百济神州	首次上榜
第 46 位	恒瑞医药	连续多年上榜
第 48 位	石药集团	重返榜单

资料来源：美国《制药经理人》杂志，中投产业研究院，国信证券经济研究所整理。

礼来样本：一款药物重写一家公司的命运

礼来这家成立于 1876 年的美国药企，2020 年在全球制药巨头中仅排第 15 位，2023 年以 341 亿美元营收排第 12 位，2024 年凭 32% 增长升至第十，2025 年营收飙升至 651.79 亿美元（同比+44.7%），跻身总营收前三；若仅论制药业务收入已问鼎第一。核心推手是其 GLP-1/GIP 双受体激动剂替尔泊肽：2025 年降糖版 Mounjaro 销售 229.65 亿美元（同比+99%）、减重版 Zepbound 收入 135.42 亿美元（同比+175%），两款合计 365.07 亿美元，占礼来全年总营收的 56%，超越诺和诺德司美格鲁肽组合（约 361 亿美元）与默沙东 K 药，成为 2025 年全球最畅销药物；礼来预计 2026 年营收 800—830 亿美元。礼来案例揭示的深层趋势是：**单一重磅品种的爆发，足以在一年内重写一家跨国药企的全球座次。**

三种创新模式：美国、欧洲、中国的生态分野

全球医药创新并非单一模式，而是三种生态深度交织、互为补充，共同构成 2025 年的“三足鼎立”。

美国模式——资本驱动的原始创新“探路者”。凭借最完备的风险投资体系、NASDAQ、FDA 通道与顶尖学术，构建“风险投资→Biotech 孵化→MNC 并购→商业化”闭环。其鲜明特征是“源头创新与平台多元”——CDER 批准新药中 First-in-class 占比超 50%；核酸药物（siRNA、ASO）、分子胶、非抗体融合蛋白等新形态持续涌现。本质是“用资本杠杆撬动全球创新”，把全球优秀管线纳入自身商业化体系。

欧洲模式——监管驱动、韧性优先的“守正者”。罗氏、阿斯利康、诺华、赛诺菲等构成全球创新药第二梯队，EMA 集中审批保障统一市场准入，长期政策支持造就全球最丰富的罕见病疗法管线。但 2025 年面临双重压力：美国 MNC 资本碾压，以及本土政策调整。

中国模式——工程师红利驱动的“追赶突围者”。在已验证靶点与技术平台（单抗、快速跟随型 ADC/双抗）的规模化、优化式创新上形成集群与效率优势；2017 年加入 ICH 后标准与国际接轨；在 ADC、双抗赛道已具“同台竞技”实力，CGT 尖端领域实现从跟跑到并跑的多点突破（如首个获批间充质干细胞疗法、B 型血友病基因治疗、CAR-T 产品获批）。本质是“用产业链效率和临床开发速度，换取全球创新版图话语权”。

礼来之变：一款药物重写一家公司的命运

要理解 2025 年全球医药格局的剧变，礼来是最具代表性的样本。这家成立于 1876 年的美国老牌药企，在 2020 年全球制药巨头中仅排第 15 位，2023 年以 341 亿美元总营收排在第 12 位，2024 年凭借 32% 的强劲增长杀至第十，而到了 2025 年，礼来全年营收飙升至 651.79 亿美元，同比增速 44.7%，成功跻身全球制药巨头总营收榜单前三；若仅论制药业务收入，礼来已经问鼎全球第一。

礼来跃升的核心推手，是其 GLP-1/GIP 双受体激动剂替尔泊肽。2025 年替尔泊肽降糖版 Mounjaro 销售额 229.65 亿美元（同比+99%），减重版 Zepbound 收入 135.42 亿美元（同比+175%），两款产品合计贡献 365.07 亿美元，占礼来全年总营收的 56%，并一举超越诺和诺德的司美格鲁肽组合（约 361 亿美元）与默沙东的 K 药，成为 2025 年全球最畅销药物。凭借 GLP-1 产品的爆发式增长，礼来完成在榜单中排名的跨越式提升，更在 2025 年 11 月成为全球首个市值突破万亿美元的药企。礼来预计 2026 年营收将达到 800 亿至 830 亿美元。

礼来的案例揭示了一个深层趋势：单一重磅品种的爆发，足以在一年内重写一家跨国药企的全球座次。这也解释了为什么 2025 年全球前 25 大药企面临到 2032 年超过 3700 亿美元的潜在增长缺口时，跨国药企纷纷将目光投向中国——通过授权合作获取中国 Biotech 的差异化管线，成为补齐自身管线的最快路径。2025 年阿斯利康与石药集团、艾伯维与荣昌生物的合作，正是这一趋势的典型体现。

三种创新模式：美国、欧洲、中国的生态分野

全球医药创新并非单一模式，而是呈现出三种各具特色的生态模式，三者深度交织、互为补充，共同构成了 2025 年全球医药产业的“三足鼎立”格局。

美国模式：资本驱动的原始创新“探路者”。美国凭借全球最完备的风险投资体系、NASDAQ 资本市场、FDA 监管通道和顶尖学术科研，构建了“风险投资→Biotech 孵化→MNC 并购→商业化”的完整闭环。美国模式的鲜明特征是“源头创新与平台多元化引领”——在其批准的 CDER 新药中，First-in-class（首创）药物占比超过 50%，凸显了基础科学研究向临床转化的强大引擎作用。从技术平台看，美国的创新生态更为发散：除了传统的化药和抗体药物，赛诺菲的靶向 SERPINC1 的 siRNA 疗法和 Ionis 的 ASO 疗法展示了核酸药物在治疗罕见病方面的巨大潜力；非降解型分子胶、非抗体类融合蛋白等新颖药物形态的出现，体现了其在前沿药物化学和蛋白质工程领域的深厚积累。美国模式本质上是“用资本杠杆撬动全球创新”——美国企业不仅自己创新，更通过资本网络将全球（尤其是中国、欧洲）的优秀管线纳入自己的商业化体系。

欧洲模式：监管驱动、韧性优先的“守正者”。欧洲在单克隆抗体药物、疫苗、血液制品、重组蛋白药物、基因治疗等方面有着显著优势，罗氏、阿斯利康、诺华、赛诺菲等构成了全球创新药的第二梯队。欧洲模式的鲜明特征是“用监管秩序守护创新质量”——EMA 的集中审批程序确保了创新药在欧盟统一市场的快速准入，而欧洲各国对罕见病药、孤儿药的长期政策支持，造就了全球最丰富的罕见病疗法管线。但 2025 年欧洲模式面临双重压力：一是美国 MNC 的资本碾压（礼来、强生、默沙东三家美国公司营收均超 600 亿美元）；二是欧洲本土政策环境的调整。2025 年 12 月欧盟就医药政策全面改革达成协议，这是“二十多年来最重大”的修订——普通药品基础保护期定为 9 年（8 年数据保护+1 年市场保护），针对未被满足的医疗需求等条件可延长至 11 年，孤儿药保护期从 10 年缩减至 9 年。这一改革的意图是“提升欧洲医药市场竞争力”，但欧洲制药工业协会联合会（EFPIA）等行业组织普遍认为改革力度不足，难以扭转投资外流趋势。欧洲模式在资本竞赛中渐显被动，但其“守正”特质——对药品质量、罕见病关怀、伦

理规范的坚守——仍是全球医药创新不可替代的稳定器。

中国模式：工程师红利驱动的“追赶突围者”。中国在将已验证靶点和技术平台（如单抗、快速跟随型 ADC/双抗）进行规模化、优化式创新方面，已形成强大集群和效率优势。中国模式的核心特征是“工程师红利+完整产业链+监管接轨”：2017 年中国加入 ICH 后监管标准与国际接轨；2025 年中国创新药 BD 出海交易总额 1356.55 亿美元、占全球 49% 首次超过美国；在 ADC、双抗等赛道，中国企业在全球范围内具备了“同台竞技”的实力。中国企业在 CGT 尖端领域实现了从跟跑到并跑的多点突破——铂生卓越的艾米迈托赛成为国内首个获批上市的间充质干细胞疗法，信念医药的 B 型血友病基因治疗产品波哌达可基、重庆精准生物的 CAR-T 产品普基仑赛的获批，标志着中国在精准化、个体化的高端生物治疗领域已经具备了完整的研发和产业化能力。中国模式的本质是“用产业链效率和临床开发速度，换取全球创新版图的话语权”。

2.3. 全球研发热点与政策重心：技术平台化与供应链区域化双轨并进

2025 年全球医药研发与政策环境同时进入深刻重构期。技术端，创新范式从“单分子突破”转向“平台化集群”；政策端，供应链安全从“效率优先”转向“韧性优先”，欧美相继推出标志性政策，中国则首次将生物医药纳入“新兴支柱产业”序列。

技术平台化：五大热点构筑下一代疗法集群

- **ADC(抗体药物偶联物)**——通过抗体与细胞毒素“偶联”实现精准打击。2025 年 ESMO 大会上，全球首个进入 III 期的 EGFR×HER3 双抗 ADC (BL-B01D1, Iza-bren) 公布多个实体瘤鼓舞数据并获 FDA 突破性疗法认定；SKB264 (TROP2 ADC)、SHR-A1811 (HER2 ADC) 等国产 ADC 进入报产阶段。
- **双特异性抗体**——2025 年康方生物依沃西单抗在 HARMONi-2 研究中作为一线疗法显著降低 PD-L1 阳性晚期非小细胞肺癌进展/死亡风险，成为 PD-1 之后的下一代免疫肿瘤核心；Summit 与康方的全球合作标志中国双抗资产获全球认可。
- **分子胶与 PROTAC**——靶向蛋白降解的“不可成药”突破口。2025 年 Monte Rosa 与诺华达成第二项合作(首付款 1.2 亿美元、总额 57 亿美元)；PROTAC 领域 FDA 已受理 vepdegestrant 新药申请。
- **细胞与基因治疗 (CGT)**——CAR-T 从血液瘤向实体瘤拓展，CRISPR 在镰状细胞贫血等遗传病取得临床进展；2025 年全球 CAR-T 管线持续扩张，中国企业约占 30% 份额。
- **AI 制药与小核酸药物**——AI 在药物发现、靶点筛选、临床设计全面渗透 (AI 对研发周期的系统性压缩详见第 4 章，此处不重复数据)；小核酸领域 2025 年全球交易总额超 364 亿美元，从罕见病工具向主流平台跨越。

供应链区域化：欧美双线推进，中国互补定位

2025 年全球医药政策核心主题是“供应链区域化”与“产业韧性优先”。美国于 2025 年 8 月 13 日签署行政命令，启动战略活性药物成分储备 (SAPIR) 计划，要求 30 天内制定关键药物清单、120 天内建成储备库并优先选用国产原料药，核心导向是保障本国关键药品供应安全。欧盟提出《关键药品法案》，2026 年 5 月 12

日欧洲议会与理事会达成临时政治协议，通过战略项目融资、采购韧性激励、供应来源多元化等机制减少对单一供应商依赖，欧盟关键药品清单已含 200 多种活性物质。中国则在 2026 年政府工作报告中首次将生物医药与集成电路、航空航天并列纳入“新兴支柱产业”，政策主线为“对内强化原始创新、对外合作共赢”，与欧美形成互补。

表9：2025-2026 年全球主要医药市场政策重心对比

国家/地区	核心政策	政策导向
美国	战略活性药物成分储备（SAPIR）计划	保障本国关键药品供应安全、增强供应链弹性
欧盟	《关键药品法案》+医药政策全面改革	提升供应链韧性、减少对单一供应商依赖
中国	新兴支柱产业定位+“推动创新药和医疗器械高质量发展”	原始创新+高质量国际合作

资料来源：商务部，中国医保商会，2026 年《政府工作报告》；《“十四五”生物经济发展规划》，国信证券经济研究所整理。

3. 国内生物医药发展现状：追赶与突围

2025 年，中国生物医药在“总量承压”与“结构跃升”的双重轨迹中完成关键一年跨越：规模以上医药工业营业收入 29562.5 亿元、同比下降 0.6%，利润 4080 亿元、同比增长 1.4%；全年批准 1 类创新药 76 个、创历史新高；创新药对外授权交易总额 1356.55 亿美元、首次超过美国。这组数据勾勒出正在发生的产业转折——中国生物医药已从“政策与资本催化的导入期”迈入“产品落地与全球验证的成长期”。以下从产业规模与结构性痛点、细分领域突围、政策与支付环境、国际化进程四个维度展开。

3.1. 产业规模与结构性痛点：全球占比提升，内卷与过剩并存

市场规模：全球第二地位稳固，占比持续提升

市场规模：全球第二地位稳固。2025 年中国生物医药整体市场规模约 2.24 万亿元人民币，占全球比重升至约 18%（医药工业口径），稳居全球第二大市场。从医药工业运行看，“营收微降、利润微增”的组合意义重大——它标志医药工业在连续三年利润下滑（-26.3%、-16.2%、-0.9%）之后首次实现利润增速转正，且利润增速高于全国工业整体 0.8 个百分点。

表10：2025 年规模以上医药工业主要经济指标（中国医药企业管理协会口径）

指标	数值	同比增速
增加值	-	3.30%
营业收入	29562.5 亿元	-0.60%
利润总额	4080 亿元	1.40%
出口交货值	4042.4 亿元	9.80%

资料来源：国家统计局、中国医药报，国信证券经济研究所整理。

表11：2025 年规模以上医药制造业企业主要经营指标（国家统计局口径）

指标	数值	同比变化
企业数量	9,875 个	0.84%

亏损企业数量	2,838 个	-
亏损企业占比	28.74%	-
营业收入	24,870 亿元	-1.20%
营业成本	14,362.4 亿元	-1.30%
利润总额	3,490 亿元	2.70%

资料来源：国家统计局、中投产业研究院，国信证券经济研究所整理。

从九大子行业看结构性分化极为剧烈：生物制品是唯一营收利润双增长的板块（营收+7.5%、利润+37.9%）；制药专用设备营收虽降 4.9%但利润逆势增 27.4%，印证“卖铲人先于淘金者兑现业绩”；其余板块普遍利润下滑，化学原料药、化学制剂、中药饮片、中成药四大板块营收利润“双降”。

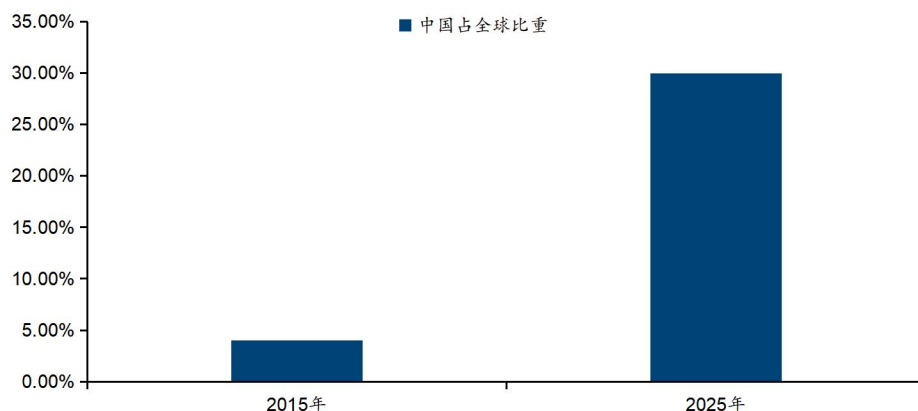
表12：2025 年中国医药工业九大子行业经营情况

子行业	营收增速 (%)	利润增速 (%)	发展阵营
生物制品	7.5	37.9	营收利润双升
化学原料药	-0.6	-4.5	营收利润双降
化学制剂	-2.1	-0.1	营收利润双降
中药饮片	-6.3	-3.7	营收利润双降
中成药	-6	-2.9	营收利润双降
制药专用设备	-4.9	27.4	增利不增收
医疗仪器设备及器械	3.4	-3.9	增收不增利
卫生材料及医药用品	0.2	-6.2	增收不增利
药用辅料及包装材料	7.7	-25.1	增收不增利

资料来源：中国医药企业管理协会，国信证券经济研究所整理。

全球占比的提升不仅体现在规模，更体现在创新分量上。2015 年中国仅贡献全球约 4%的创新研发管线，2025 年在研新药管线约占全球 30%、位列全球第二；拥有活跃研发管线的企业超 1180 家，同样居全球第二。麦肯锡报告显示，截至 2025 年 9 月，全球处于临床 I / II 期的下一代疗法管线资产中，中国贡献 34%、仅次于美国的 39%。这一跃迁速度在全球医药创新史上罕有先例。

图4：2015-2025 年中国在研管线全球占比变化（单位：%）



资料来源：麦肯锡，国家药监局，国信证券经济研究所整理。

结构性痛点：两大顽疾亟待破解

顽疾之一：低端仿制药产能过剩，集采常态化下矛盾激化。2025 年仿制药仍占化学药市场约 70% 份额。而国家集采已开展至第十一批，覆盖药品超过 300 种，累计节约医保基金约 4400 亿元，平均降价幅度超过 50%。据国家统计局口径，2025 年约 28.74% 的规上医药制造业企业出现亏损；第 43 届全国医药工业信息年会披露，2025 年百强医药工业企业主营收入回落至 10002.2 亿元、连续四年回调，百强中仅 34 家“双增长”，“双下降”企业多达 35 家、首次超过“双增长”企业。这一矛盾的实质是：过去建立在仿制药高毛利、低研发投入之上的增长模式被集采打破，企业要么向创新转型、要么被淘汰。

顽疾之二：创新药“内卷”严重，热门靶点同质化白热化。2025 年虽批准 1 类创新药 76 个创新高，但靶点高度集中——PD-1/L1、HER2、EGFR 等热门靶点在研管线数量超过全球一半。以 PD-1 为例，国内已有超 10 款单抗获批，年治疗费用被价格战压至 3—5 万元。根源在于 Biotech 过去过度集中于“快速跟随”，缺乏真正的 First-in-class 能力——2025 年全球 First-in-class 药物中，中国企业贡献仍不足 10%。更值得警惕的是，内卷已向 ADC、双抗等新赛道蔓延：尽管中国在全球 ADC 在研管线占比 54%、双抗占比 48%，但相当一部分仍是相同靶点的重复布局，直接导致 BD 出海议价能力下降。

3.2. 细分领域突围现状：创新药全球竞争力显现，CXO 面临地缘重构

创新药：ADC 与双抗成为全球突围的“双核”

2025 年中国创新药在 ADC 和双抗两大赛道实现从“跟跑”到“并排跑”、局部“领跑”的历史性跨越。全球临床阶段 ADC 项目约 370 个，中国原研占比达 54%；全球双抗管线中国占比 48%，PD-1/VEGF 等热门组合临床进度领先。2025 年 ASCO 年会上，中国贡献 11 项 ADC 口头报告、占比近三成。

ADC 领域突破尤为显著：荣昌生物维迪西妥单抗（HER2 ADC）联合 PD-1 治疗尿路

上皮癌的Ⅲ期研究 ORR 提升至 73.2%、死亡风险降低 58%，推动 NCCN 指南更新；技术层面国产 ADC 连接子从不可裂解向可裂解升级、载荷向拓扑异构酶抑制剂创新，并拓展至 TROP2、Claudin18.2、B7-H3 等新靶点。截至 2025 年 10 月，中国管线占全球双抗 ADC 的 53%（150/282）、双载荷 ADC 的 61%（34/56），在 ADC “下一代形态”上已占据全球研发制高点。

双抗领域代表案例是康方生物：其 PD-1/CTLA-4 双抗（AK104）将复发/转移性宫颈鳞癌 ORR 提升至 47.6%，3 级及以上治疗相关不良事件降至 12.9%，已获 FDA 快速审批通道资格。2025 年三生制药与辉瑞就 PD-1/VEGF 双抗 SSGJ-707 达成合作，辉瑞以 12.5 亿美元首付款获海外权益、叠加最高 48 亿美元里程碑付款，创国产创新药单药出海首付款历史最高纪录，标志中国双抗资产获全球 TOP 级 MNC “定价权认可”。

CXO：全球市占率持续提升，地缘政治引发供应链重构

依托工程师红利、成本优势与全产业链配套，中国 CXO 全球市占率稳步增长。药明康德 2025 年营业收入 454.56 亿元、同比增长 15.84%，剔除一次性收益后归母净利润 191.51 亿元、同比增加 32.56%；更值得注意的是，在《生物安全法案》从提出到推进立法的两年间，药明康德在美订单不降反升，从 2023 年 261.3 亿元升至 2025 年 312.5 亿元、收入贡献从 65%升至 72%，证明中国 CXO 在化学药 CDMO 领域短期具有不可替代性。

但地缘风险在 2025 年 12 月进入实质落地阶段：美国《2026 财年国防授权法案》夹带《生物安全法案》（主要指第 851 节）生效，标志美国将生物安全正式纳入国家防务框架，法案通过缓冲期、动态名单机制实现温和落地，短期对我国 CXO 订单业绩影响相对有限。长期看供应链重构挑战真实存在——2024 年美欧日印韩成立“生物制药联盟”，目标是构建相互信任、可持续的供应链体系。分领域看：化学 CDMO 中国 5 年内具较强不可替代性（人才、化学能力、合规产能、IP 保护综合领先）；生物药 CDMO 中欧美日韩同台竞技（Lonza 2025H1 营收增 17.0%、Samsung Biologics 近年增速维持 20%以上）；XDC（ADC 等偶联药物）CRDMO 是中国 CXO 在新分子浪潮中最确定的突围方向（龙头药明联合全球市占率持续提升）。

2026 年 6 月，药明康德被列入 1260H 清单，A+H 再度双双下跌超 7%、单市市值蒸发逾百亿元，但营收曲线依然上扬。这一“股价跌、订单涨”的背离，深刻揭示了中国 CXO 的产业韧性：短期海外药企在“谁更好”与“谁更安全”的权衡中仍难彻底放弃中国供应链；真正的挑战在于当供应链重构进入深水区，中国 CXO 须通过海外基地建设和 XDC 等新赛道卡位，主动对冲地缘风险。

3.3. 政策与支付环境：从“加速审批”到“全链条支持”

审评端：CDE 新政 CDE 从“加速”转向“提质”

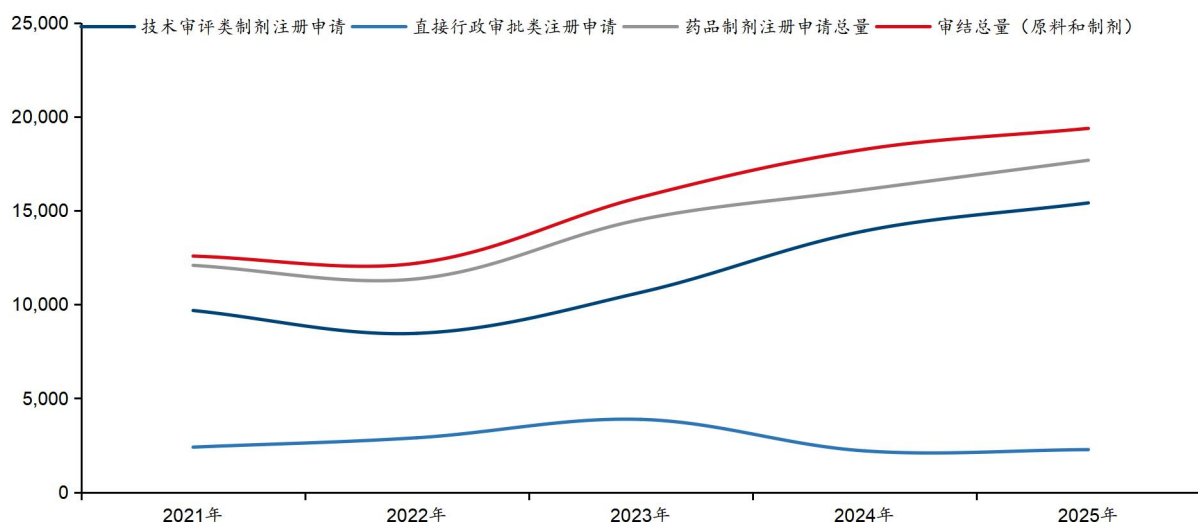
2025 年 CDE 审评导向发生微妙但关键的变化。全年批准 1 类创新药 76 个，其中新机制新靶点药物 11 个、26 个经优先审评审批上市、15 个附条件批准、15 个在临床期间纳入突破性治疗程序。审批速度依然很快，但深层变化在于 CDE 对同质化创新的容忍度正在降低：对 PD-1、HER2、EGFR 等拥挤赛道的新申报要求提供更充分的差异化证据；附条件批准后的确证性研究时限被严格执行，未按期完成者面临撤市风险。直接后果是 2025 年 IND 申报增速放缓、但临床成功率有所提升——CDE 正用审评标准这把“手术刀”切除内卷病灶。

表13：2025 年国家药监局审评审批主要成果

指标	数值	同比/备注
药品上市注册申请批准量	4,087 件	—
创新药批准量	76 个	创历史新高
境外新药临时进口批准	59 件	境内外上市时间差进一步缩短
儿童药批准量	138 个	创历史新高
罕见病药品批准量	48 个	—
医疗器械批准量	3,402 个	—
创新医疗器械批准量	76 个	再攀新高
优先审批医疗器械	25 个	同比增长 212.5%

资料来源：国家药监局（新华社报道，2026 年 1 月）、中投产业研究院，国信证券经济研究所整理。

图5：2021–2025 年药品注册申请审结量（单位：件）



资料来源：国家药品监督管理局，国信证券经济研究所整理。

与此同时，2026 年 1 月全国药品监督管理工作会议提出“助力创新药中国首发”，对新机制、新靶点创新药在沟通交流、临床试验、注册申报、审评审批全链条强化服务支持。这意味着未来中国创新药企有望在境内实现与全球同步甚至领先的新药首发，而不必再“绕道”FDA——深层逻辑是中国医药市场规模已居全球第二，具备支撑“中国首发”的商业基础。

支付端：医保集采与国谈常态化，“全链条支持”政策实质性落地

集采与国谈进入“存量博弈”。2025 年国家集采已开展至第十一批，覆盖药品超 300 种，累计节约医保基金约 4400 亿元，平均降幅超 50%。医保国谈每年一次，2025 年医保目录新增 114 种药品（其中 50 种为 1 类创新药），创新药平均降价幅度从 2020 年约 50%收窄至约 35%，体现政策对创新价值的适度尊重。

表14： 2025 年底国家组织药品集采核心数据

指标	数据
集采批次	11 批
累计节约医保基金	约 4,400 亿元
第十批集采品种	62 种
第十批平均降幅	超 60%
第十一批集采品种	55 个
第十一批参与企业	445 家, 794 个产品
第十一批拟中选	272 家企业, 453 个产品

资料来源：国家医保局，国信证券经济研究所整理。

“全链条支持”政策实现“增量突破”。2025 年 7 月国家医保局、国家卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》（医保发〔2025〕16 号），核心是增设商业健康保险创新药品目录，与基本医保目录形成“双目录”分轨管理——基本医保覆盖临床必需基础药品，商保创新药目录重点纳入超出基本医保范围、创新程度高、临床价值大的高值创新药。2025 年 12 月 7 日首版商保创新药目录正式发布，纳入 19 种药品，含 CAR-T 细胞治疗产品（阿基仑赛、瑞基奥仑赛）和多款罕见病药物；目录内药品医保基金不予支付、不计入基本医保自费率指标，为高值创新药开辟全新支付通道。

商保的实际效果仍待检验，但制度框架已搭建完毕，2026 年政府工作报告提出“加快发展商业健康保险”，预计“十五五”期间商保将成为创新药支付的重要增量。

3.4. 国际化现状：从 License-in 到 License-out 的历史性逆转

2025 年中国创新药 BD 出海交易总额 1356.55 亿美元、首付款 70 亿美元、交易 157 起，占全球 License-out 交易总额 49%，首次超过美国。这组数字标志中国生物医药国际化完成从 License-in（引进）到 License-out（授权出海）的历史性逆转。

回溯 2015—2020 年，中国生物医药产业的主导模式是 License-in：从海外引进临床前或早期管线、在境内完成开发上市，典型代表是再鼎医药，本质是“用中国市场换海外技术”。2020 年后 License-out 渐增，但直到 2023 年其总金额仍低于 License-in。2025 年天平彻底倾斜——157 起交易、1356.55 亿美元总额、70 亿美元首付款背后，是中国在 ADC、双抗、CAR-T 等赛道积累的系统性研发能力获得全球认可；ADC 与双抗贡献近 60%交易额，单笔首付款超 1 亿美元的交易达 15 起。

相较出海 1.0（数量超越），出海 2.0 实现了从“卖青苗”到“全球合伙人”的范式升级。2025 年交易结构变化体现在三个维度：

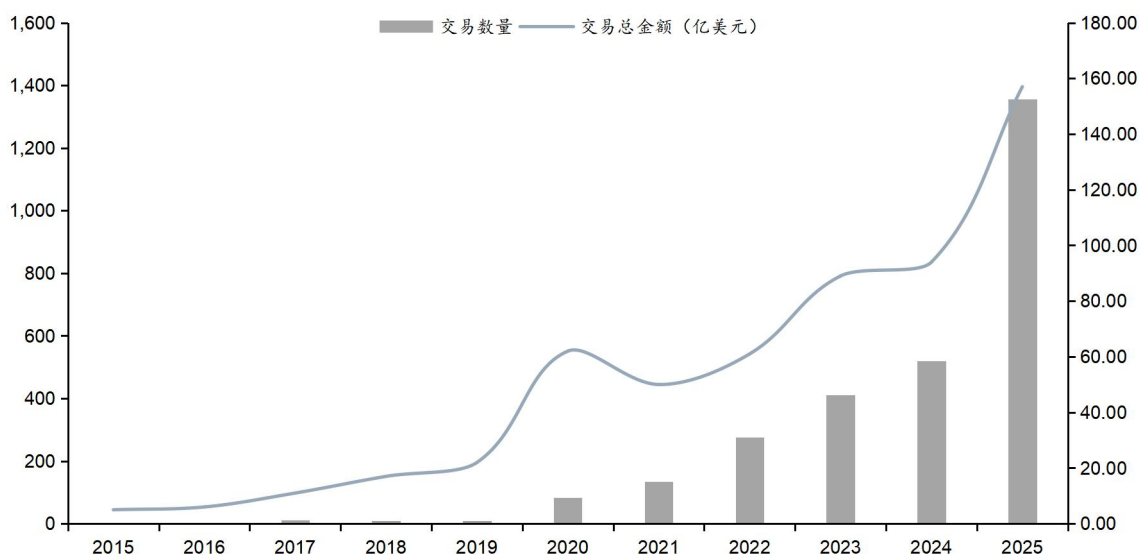
维度一是首付款大幅提升，中方议价能力根本性增强。单笔首付款纪录不断刷新：三生制药与辉瑞 SSGJ-707 的 12.5 亿美元首付款创国产单药出海历史最高；百济神州塔拉妥单抗以 8.85 亿美元首付款与 Royalty Pharma 成交。中方地位从“求着卖”到“挑着卖”。

维度二是 NewCo 模式兴起，中方掌握更大话语权。将特定管线海外权利授权给海外新公司、同时引入海外基金与国际化团队。2025 年全年完成 9 起 NewCo 交易，恒瑞医药是重要践行者（9 月将 HRS-1893 授权美国 Braveheart，获 6500 万美元

首付款含现金与等值股权），中方成为新公司股东和共同决策者。

维度三是从“产品授权”到“平台合作”，中国技术获系统性认可。恒瑞将 HRS-9821 及至多 11 个临床前项目“选择权”授权 GSK，结构含 5 亿美元预付款、潜在 120 亿美元里程碑及销售分成；科伦博泰将 TROP2 ADC 平台授权默沙东、总额超 100 亿美元。MNC 认可的不再是单个管线，而是中国企业在特定技术平台上的系统性研发能力。

图6：2015-2025 年中国药企 Licence-out 交易数量及金额（单位：件，亿美元）



资料来源：医药魔方 NextPharma®全球新药数据库，国信证券经济研究所整理。

4. 行业趋势演进：全球与中国的双轨变革

2025 年，全球与中国生物医药在看似不同的轨道上同步加速，却指向同一终局——全球医药创新价值链的重构。一边是跨国药企面对专利悬崖，从“内部研发”转向“外部寻宝”，全球并购与授权创下近十年新高；另一边是中国创新药企在政策、资本、技术三重共振下，从“破局内卷”走向“全面出海”。两条轨道深度咬合：中国正成为 MNC “外部寻宝”的核心目的地，而 MNC 的“外部寻宝”又倒逼中国药企加速向全球价值链上游攀升。

4.1. 全球趋势演进：技术迭代与产业重构

技术趋势：AI 制药从“概念验证”走向“工业化部署”

2025 年 10 月，中国科学院院士陈凯先披露：传统药物发现与临床前研究需 3—6 年、平均投入 5 亿美元，AI 介入后可缩短至 1.5—3.6 年、全球每年节约 260 亿美元；临床研究阶段从 6—7 年压缩至 2.4—3.5 年、每年节约临床费用 280 亿美元。整体看，AI 可使总研发周期平均缩短 1/3 至 1/2、总研发经费降低 10%、总成功率由 10%提升至 14%。

表 15: AI 赋能下药物研发周期对比

研发阶段	传统周期	AI 赋能后周期	节约时间
药物发现与临床前研究	3-6 年	1.5-3.6 年	节约约 40%
临床研究	6-7 年	2.4-3.5 年	节约约 50%
临床前制剂开发	1-2 年	3 个月以内	节约 75%以上
整体研发周期	10-15 年	缩短 1/3 至 1/2	经费降低 10%，成功率 10%→14%

资料来源：博策咨询，陈凯先院士 2025 年 10 月披露，国信证券经济研究所整理。

这一红利在中国企业身上快速验证：英矽智能从靶点发现到临床前候选药物平均周期仅 12—18 个月（传统 4.5 年）；剂泰科技将临床前制剂研发周期由 1—2 年压缩至 3 个月以内。

产业趋势：MNC 应对专利悬崖，从“内部研发”转向“外部寻宝”

安永 2026 年白皮书估计，全球前 25 大生物制药企业到 2028 年将面临约 1000 亿美元增长缺口、到 2032 年缺口超 3700 亿美元；截至 2025 年，全球生命科学行业可用于并购及合作的资金约 2.1 万亿美元，收购与合作成为 MNC 弥补缺口的有效手段。这一转向在交易数据中充分体现。

表 16: 2025 年全球医药交易与并购核心数据

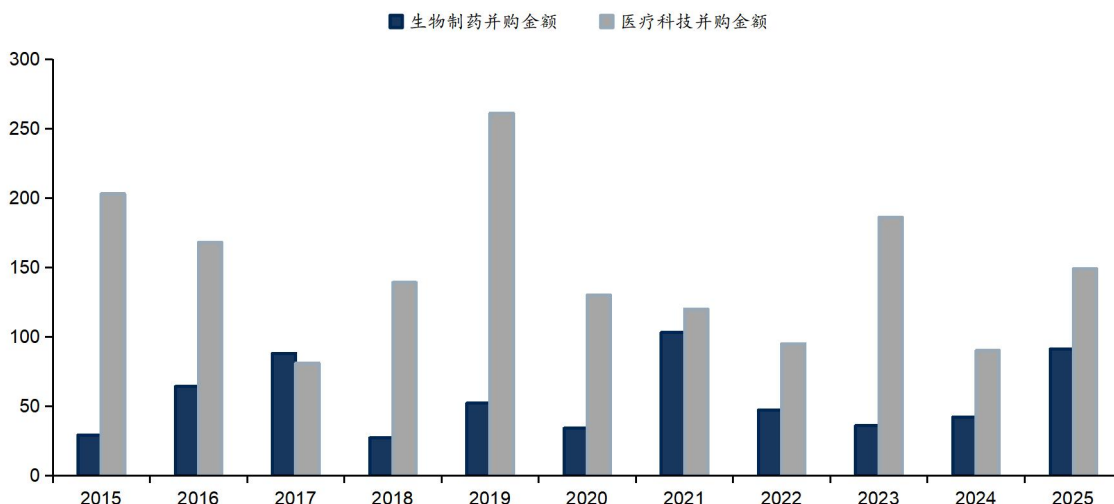
指标	2025 年数据	同比/占比	产业含义
全球医药交易数量	突破 1000 笔	规模仅次于 2020-2021 年	交易创十年新高
全球交易总金额	2751 亿美元	近十年新高	MNC 加速外部寻宝
全球首付款总额	188 亿美元	—	资产争夺白热化
Top 20 MNC 境外交易中临床前项目占比	75%	—	“向前布局”战略
全球医药并购总金额	1414 亿美元	同比+129%	精选优质资产
前十大 MNC 并购金额占比	985 亿美元	占全球 69.7%	高度集中
MNC 与中国企业交易总金额	692 亿美元	占 MNC 全球引进 40%	中国资产刚性需求

资料来源：安永，国信证券经济研究所整理。

注：表中“全球交易总金额 2751 亿美元”为医药 BD/授权交易总额口径，中国 License-out 的 1356.55 亿美元已计入其中；“692 亿美元”为 MNC 自中国引进交易总额，为其全球引进总额的 40%。

境外交易呈“精选化、平台化、早期化”特征：Top 20 MNC 境外交易中临床前项目占比高达 75%，约 20%集中在 AI 药物发现平台合作，ADC 和双抗类项目占比达 27%；超 10 亿美元重磅并购达 33 笔，前十大 MNC 并购占全球 69.7%。中国资产在 MNC“外部寻宝”中的战略地位尤为突出：2025 年 Top 20 MNC 与中国企业交易 37 笔、占其全球引进交易总数的 21%，交易总额 692 亿美元、占比达 40%，远超其对美国企业的交易额；中国药科大学生物医药战略研究院预计，2026—2027 年 MNC 年度引进交易中中国资产占比有望突破 50%。

图7：2015-2025 年全球生命科学行业并购趋势（单位：十亿美元）



资料来源：安永，国信证券经济研究所整理。

4. 2. 国内趋势演进：破局内卷与全面出海

研发趋势：低水平重复管线加速出清，向 First-in-class 艰难跨越

2025 年批准 1 类创新药 76 个、较 2024 年大幅增长 58.3%、创历史新高；但结构上，全新机制的 First-in-class 仅 11 个、其中自主研发仅 4 个（作为对照，FDA 2025 年批准 46 款新药）——中国创新药数量已全球领先，但真正的“头部创新”依然稀缺。破局内卷的核心抓手是监管导向调整（CDE 对拥挤赛道要求差异化证据、严格执行确证性研究时限、“中国首发”全链条支持，已在第三部分进行了阐述，此处不重复）。从在研管线看，中国约占全球 30%、位列第二；2025 年获批 76 款新药中，抗体药物 10 个、重组蛋白 4 个、细胞基因疗法 3 个、ADC 3 个、基因疗法 1 个、多肽药物 1 个，多元化创新疗法加速上市，但靶点集中度依然偏高（PD-1/L1、HER2、EGFR 在研管线超全球一半）。这种“数量领先、首创不足”的格局，正是向 First-in-class 跨越的最大障碍。

商业化趋势：从“产品出海”升级为“技术出海”和“产能出海”

医药魔方 NextPharma 数据库显示，2025 年对外授权交易总额 1356.55 亿美元（为 2024 年 2.5 倍）、首付款 70 亿美元、交易 157 起、占全球 License-out 总额 49%、首次超越美国。

产品出海量价齐升：首付款 70 亿美元已超一级市场融资规模（第一部分口径下国内一级市场融资约 96 亿美元宽口径/323.54 亿元窄口径；BD 首付款作为新增现金流支柱与之并列讨论，标志行业从“融资驱动”向“交易驱动”转型）；全球前十大 License-out 交易中国占据七席。

技术出海实现平台化突破：ADC 项目在 License-out 总金额中的占比从以往近半降至 2025 年的 13%，小分子、双/多抗、融合蛋白、小核酸等类型均实现突破；更具标志性的是“平台授权”出现——恒瑞将 HRS-9821 及至多 11 个临床前项目授权 GSK（含 5 亿美元预付款、潜在 120 亿美元里程碑）、晶泰科技与 DoveTree 达成 59.9 亿美元交易（中国 AI 制药领域最大 BD 交易），标志中国创新药从“卖产品”向“卖能力”转型。

产能出海与合伙人模式起步：百济神州在美国建成自有商业化团队，泽布替尼全球销售额 280.67 亿元中美国市场贡献超 60%；合作模式从传统 License-out 向 NewCo、Co-Co 演进——2025 年 NewCo 完成 9 起交易，信达生物与武田达成 114 亿美元 Co-Co 交易（双方按 40/60 分摊开发成本、共享美国市场利润），超越简单“卖青苗”模式。

支付趋势：多层次支付体系加速构建，商保成为创新药“第二战场”

2025 年中国商业健康保险对创新药械的支付规模达 152 亿元、同比增长 23%，但仅占创新药械市场 1950 亿元销售规模的 7.8%，与美国商业健康险占医疗支出超 35% 的差距悬殊——但趋势已经明确。一是**商保保费规模持续增长**：国家金融监督管理总局数据显示，2025 年商业健康险保费规模达 9973 亿元、近十年复合增长率 15.3%。二是**“双目录”机制实质落地**：2026 年 5 月国家医保局发布目录调整工作方案，首次打通基本医保目录与商保目录的衔接通道、新增“预申报”机制，预计可将创新药从上市到进医保的周期缩短约一年。

5. 市场空间预测：基于政策框架的情景分析

5.1. 测算框架与方法论

本预测摒弃简单线性外推，构建“政策牵引+市场扩容+结构跃升”三维动态框架。核心逻辑在于：中国医药市场的增长已从“规模红利”转向“政策红利”与“创新红利”双重驱动，单纯用历史增速外推，会忽视支付体系重构与出海模式升级带来的非线性变化。

核心观测指标：选取“规模以上医药工业营业收入”（涵盖化学药、生物药、中药及医疗器械），2025 年基数 29562.5 亿元（中国医药企业管理协会《2025 年医药工业经济运行情况》）；同时以国家统计局医药制造业营收 24870 亿元作为辅助验证口径。两口径差异源于统计边界不同，本测算以较宽的“医药工业”口径为主。

政策乘数（商保）：2025 年商业健康保险对创新药械支付 152 亿元，占创新药械市场 1950 亿元的 7.8%。商保目录扩容节奏（2025 年首版 19 种，2026 年预计扩至 40—50 种）是本模型最重要的政策变量。

结构性增量（创新药）：弗若斯特沙利文预测中国创新药市场 2024—2030 年 CAGR 约 8.9%；瑞银预测创新药板块同期年化增速更高。本测算创新药基准情景取弗若斯特沙利文 8.9%口径。

风险对冲：在中美监管博弈背景下，假设技术出海受阻将对估值产生 10%—15%折价；《生物安全法案》随 NDAA 生效、欧盟《关键药品法案》推进均构成潜在下行风险，谨慎情景已纳入此系数。

需要强调的是，规划目标不能作为预测锚点，必须以 2025 年实际结构为起点，充

分考虑集采冲击、行业调整等惯性。因此基准情景 CAGR 设定在 6.5%—7.5%，低于“十四五”规划隐含的 8%以上目标。

5.2. 测算结果：三情景下的市场空间

基于上述框架，以 2025 年医药工业营收 29562.5 亿元为基数推演未来五年。所有预测均基于当前可见政策框架与技术趋势，未纳入重大突发公共卫生事件或颠覆性技术突破等不可预见因素。

表 17：2025—2030 年中国医药工业营收三情景测算（单位：亿元）

年份	谨慎情景（CAGR 约 4.5%）	基准情景（CAGR 约 7.0%）	乐观情景（CAGR 约 9.5%）
2025（实际）	29562.5	29562.5	29562.5
2026	30900	31600	32400
2027	32300	33800	35400
2028	33700	36200	38800
2029	35300	38800	42500
2030	36000—37700	40500—42400	45500—46500

资料来源：中国医药企业管理协会《2025 年医药工业经济运行情况》，弗若斯特沙利文、瑞银预测，国信证券经济研究所测算。

基准情景（概率 60%）：政策稳步落地，商保加速扩容。假设集采常态化推进但降幅趋缓（平均降幅从 50%收窄至 30%），创新药审批与支付政策持续优化，商保创新药目录年均扩容 20—30 种，BD 出海保持年均 15%—20%增长，全球地缘风险可控。年均复合增长率 6.5%—7.5%。2030 年医药工业营收预计达 4.05—4.24 万亿元，较 2025 年增长约 37%—43%。利润端因创新药占比提升而改善，2030 年利润约 5800—6200 亿元、CAGR 约 7%—9%。

乐观情景（概率 20%）：技术出海爆发，AI 制药重塑效率。假设商保支付突破性增长（152 亿元若年均增长 40%以上，2030 年可达约 820 亿元），出海 2.0 全面铺开（NewCo、Co-Co 成主流），AI 制药显著降低研发沉没成本。年均复合增长率约 9%—9.5%。2030 年营收有望达 4.55—4.65 万亿元。出海收入贡献率超 20%，中国在全球创新药供应中的规模与影响力进一步巩固。

谨慎情景（概率 20%）：宏观承压，支付端收紧。假设地缘风险加剧（《生物安全法案》扩大适用、欧盟出台类似限制），医保筹资增速放缓，创新药出海遇阻，集采降幅维持高位。年均复合增长率 4%—5%。2030 年营收约 3.60—3.77 万亿元，行业进入存量博弈，企业利润空间受挤压。

创新药市场规模作为结构性增量单独建模，采用弗若斯特沙利文终端市场口径（2025 年约 1.2 万亿元）。

表 18：2025—2030 年中国创新药市场规模三情景测算（单位：亿元）

年份	谨慎情景（CAGR 约 5%）	基准情景（CAGR 约 8.9%）	乐观情景（CAGR 约 11%）
2025（实际）	约 12000	约 12000	约 12000
2026	12600	13100	13300
2027	13200	14200	14800
2028	13900	15500	16400

2029	14600	16900	18200
2030	约 15300—15500	约 18400—19500	约 20200—22000

资料来源：弗若斯特沙利文、瑞银、中商产业研究院预测，国信证券经济研究所测算。

注：本表为中国创新药终端市场规模口径，与医药工业营收口径统计对象不同。

5.3. 增长驱动：三股力量贡献增量

在基准情景下，未来五年增长并非均匀分布，而由三股核心力量主导——它们的合力使 2030 年营收的“含金量”远高于当前。

一是支付体系的“补短板”效应。 中国创新药长期依赖基本医保单一支付方，商保对创新药械支付占比不足 8%，远低于发达国家。随着“双目录”机制实质落地与个人医疗险快速增长，商保正成为创新药支付的“第二战场”。其深层意义不在短期增加多少额度，而在于为创新药建立了一套独立于医保谈判的价格体系——商保目录内药品可不纳入集采替代品种监测、不计入医院自费率指标，企业由此获得更高定价弹性。当商保支付占比从不足 8% 提升至 15% 以上时，创新药商业化底层逻辑将改变：药企不再需要在“进医保降价”与“不进医保没销量”之间做零和博弈。

二是创新管线的“变现”能力升级。 中国创新药出海正从“卖青苗”转向“卖能力”。早期出海是将临床早期管线低价授权、中方控制权有限；出海 2.0 特征是首付款大幅提升、合作模式多元化（NewCo、Co-Co）、MNC 对中国技术的认可从“个案”升级为“系统性”。驱动力来自两端：需求侧，全球前 25 大药企面临到 2032 年超 3700 亿美元的增长缺口，对中国资产引进需求刚性；供给侧，中国在 ADC、双抗等赛道积累的系统性研发能力已获全球验证。

三是技术迭代的“降本增效”效应。 AI 制药正从概念验证走向工业化部署，其深层影响不是简单“加速”，而是系统性降低研发风险与成本。传统研发“双十定律”正被打破——AI 可将药物发现与临床前研究缩短约 40%、临床研究缩短约 50%、整体研发成功率从 10% 提升至 14%。产业意义在于：当研发成本与风险下降，药企敢于尝试更多高风险、高回报的 First-in-class 靶点，而非扎堆已验证的热门靶点——AI 因此成为破解“靶点内卷”的技术杠杆。

结构优化重于总量扩张。 中国医药产业的未来不在于做大绝对规模，而在于结构显著优化。基准情景下，创新药市场规模从 2025 年约 1.2 万亿元升至 2030 年约 1.84—1.95 万亿元、增速持续高于医药工业整体，出海收入贡献显著抬升——这一结构性转变才是未来五年最值得关注的趋势，而非总量数字本身。

6. 结论与建议

6.1. 研究结论：全球格局重构、中国角色跃迁、增长瓶颈待破

本研究通过对全球与中国生物医药产业的系统梳理与独立情景建模，得出以下核心判断。

第一，全球医药产业正经历新一轮权力重构，中国从“跟跑者”跃升为影响格局的关键变量。 2025 年全球医药市场约 1.785 万亿美元，生物药占比首次超越化学药、突破 52%，“大分子时代”正式到来；礼来凭替尔泊肽一年内从全球第十二跃至第三，印证单一重磅品种足以重写 MNC 座次。在此重构中，中国角色发生

质变：创新药研发贡献度从十年前不足 5% 跃升至近 40%，BD 出海交易总额首次超越美国，中国差异化管线成为 MNC “外部寻宝” 核心目标（2025 年中国资产占 MNC 引进交易总额 40%）。

第二，中国生物医药正处于从“跟跑”向“并跑”跨越的关键阶段，“数量领先、首创不足”的结构性矛盾正在加速化解。2025 年批准创新药 76 个创历史新高、在研管线约占全球 30%、产业规模全球第二；但更值得关注的是结构性积极变化——76 个创新药中全新机制首创药 11 个（历史最好水平），BD 首付款 70 亿美元首次超过一级市场融资规模，标志创新药企开始具备“自我造血”能力；出海模式从“卖青苗”升级为“卖能力”、从产品授权升级为平台合作。2026 年政府工作报告将生物医药纳入“新兴支柱产业”，是对这一趋势的制度确认。

第三，未来五年的增长空间来自结构优化而非总量扩张，支付体系重构是释放潜力的关键瓶颈。本研究独立测算显示：基准情景下 2030 年医药工业营收约 4.05—4.24 万亿元（较 2025 年增长约 37%—43%），创新药终端市场约 1.84—1.95 万亿元。增长主要来自三股结构性力量的合力：商保支付占比从不足 8% 提升带来的支付体系重构、出海模式升级带来的价值链攀升、AI 制药降低研发成本风险带来的效率革命。但当前最紧迫的瓶颈在支付端——2025 年商保对创新药械支付仅 152 亿元、占 7.8%，远低于发达国家；若支付体系无法实现从“单一医保依赖”向“多元支付支撑”跨越，创新药商业化闭环将始终存在短板，产业“成长期”可能被拉长。

6.2. 发展建议：出海升维、支付补短、技术赋能

基于上述结论，面向行业未来发展，提出三个方向性的建议。

一是将“出海”从战术选择上升为战略必然，以全球标准倒逼产业能力升级。出海的意义不应局限于短期现金流，更在于通过与 MNC 深度合作，倒逼研发标准、质量管理、合规体系向全球最高水平看齐。建议行业层面推动国际多中心临床试验协作网络、降低中小企业出海合规成本；企业层面从管线立项之初即以全球市场为目标。当“出海”从头部企业的“加分项”变成全行业“必答题”，中国医药产业才能完成从“内需驱动”向“全球竞争”的范式切换。

二是加快构建多层次支付体系，让商保成为创新药商业化的“第二引擎”。“双目录”机制已打开制度通道，但距真正发挥“第二引擎”作用仍有较大距离。下一步应扩大商保目录覆盖范围、鼓励开发与健康管理结合的创新药专属险种、探索医保与商保的数据互通和联合定价，并推动医疗机构对商保目录药品的处方开放与报销简化，让制度设计真正转化为患者可及性。

三是拥抱技术变革，以 AI 和数字化重塑产业效率，破解“靶点内卷”困境。AI 制药可将研发周期缩短三分之一至一半、成功率从 10% 提升至 14%，其产业意义不仅在降本增效，更在于有望改变“扎堆热门靶点”的路径依赖。建议行业层面推动共享 AI 药物发现平台与高质量数据集、降低中小 Biotech 技术门槛；企业层面将 AI 能力内化为核心研发流程。率先完成数字化转型的企业将在下一轮竞争中占据先机，产业也有望借此实现从“快速跟进”到“原始创新”的跨越。

风险提示

政策不及预期。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032